LICENCE 3 · SEMESTRE 5 · FICHE DE RÉVISION

Initiation au droit de la protection sociale



Céline Leborgne-Ingelaere · Université de Lille

Édition 2026-2027 · Fiches 1 à 4

Ce cours en quatre fiches présente le **système français de protection sociale** : ses notions de base et ses enjeux (fiche 1), l'organisation et le financement de la **sécurité sociale** (fiche 2), l'**aide et l'action sociale** et l'**assurance chômage** (fiche 3), puis les grands risques **maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles** (fiche 4). Fil rouge : la **solidarité nationale**, et ses différentes logiques (assurance, assistance).

Définition · Texte · Jurisprudence · Exemple · Piège · À retenir

Sommaire

Fiche 1 : présentation générale de la protection sociale (définitions ; sécurité sociale ; régimes complémentaires et supplémentaires ; chômage ; aide et action sociale ; la crise de l'État-providence)

Fiche 2 : le système de sécurité sociale

Fiche 3 : l'aide et l'action sociale ; l'assurance chômage

Fiche 4 : l'assurance maladie, maternité et les risques professionnels

Synthèse

FICHE 1

Présentation générale de la protection sociale

LE FONDEMENT CONSTITUTIONNEL : ALINÉA 11 DU PRÉAMBULE DE 1946

« Tout être humain qui, en raison de son **âge**, de son **état physique ou mental**, de la **situation économique**, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des **moyens convenables d'existence**. »

LE POIDS ÉCONOMIQUE (DREES)

Prestations de protection sociale en **2024 : 932,5 milliards d'euros**, soit **31,9 % du PIB** (moyenne UE à 27 : 27,3 %) : la France est **2e en Europe**, derrière la Finlande. **Retraites et santé** représentent les **quatre cinquièmes** des dépenses.

I Définitions

1. La protection sociale

PROTECTION SOCIALE ET RISQUE SOCIAL

La **protection sociale** : l'ensemble des institutions et dispositifs qui protègent les individus ou ménages, tout au long de leur vie, contre les conséquences de la survenance de **risques sociaux**. Le **risque social** menace ceux qui vivent en société : un événement qui entraîne soit une **augmentation des besoins** (maladie, famille), soit une **perte de ressources** (vieillesse ; altération physique de la force de travail ; altération économique : chômage).

Convention n° 102 de l'OIT (28 juin 1952), norme minimum

Neuf branches : soins médicaux, indemnités de maladie, chômage, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, prestations familiales, maternité, invalidité, survivants.

Comptes de la DREES

Six grands risques : santé, vieillesse-survie, famille, emploi, logement, pauvreté-exclusion sociale.

Les techniques possibles pour se prémunir contre un risque social :

Technique	Limites
Épargne individuelle	La plus inefficace : les plus vulnérables ne peuvent pas épargner, l'érosion monétaire ruine les efforts, et l'individu risque de ne pas couvrir son propre risque
Assistance (charité privée ou publique : Église, roi, corporations, paroisses, familles)	Son caractère **facultatif** la rend impuissante à couvrir tout le monde
Responsabilité civile	Il faut un **responsable solvable** et, souvent, la preuve d'une **faute**. Utilisée pour les accidents du travail avant **1898** ; la loi de 1898 la remplace par une indemnisation **forfaitaire** fondée sur le **risque professionnel**, sans faute à prouver
Assurance / mutualisation	La plus performante : le risque est réparti sur la collectivité des bénéficiaires contre une prime ou une cotisation

Le système français **combine** ces techniques. La protection sociale y englobe : la **sécurité sociale**, l'**aide sociale**, l'**assurance chômage** et la **protection sociale complémentaire**.

2. La sécurité sociale

Il n'existe pas de définition universelle. Le Code de la sécurité sociale en donne le fondement et les objectifs :

> **ART. L. 111-1 CSS**
>
> La sécurité sociale est fondée sur le principe de **solidarité nationale**. Elle assure, pour toute personne **travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière**, la couverture des charges de **maladie**, de **maternité et de paternité** ainsi que des charges de **famille** et d'**autonomie**. Elle garantit en outre les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leurs revenus, par leur **affiliation** à des régimes obligatoires.

- Définition doctrinale : une institution ou un ensemble d'institutions visant à garantir la **sécurité économique** des individus de toutes conditions et à les protéger contre les risques sociaux ; une organisation collective, expression de la solidarité nationale, qui assure la **couverture sociale de base**.
- Idée fondatrice : il serait injuste que le **hasard** pénalise des personnes non responsables de ce qui leur arrive. On privilégie aujourd'hui les solidarités **entre générations** et **entre actifs et chômeurs**, plus que les solidarités de classe.

- **1898** : loi sur les accidents du travail (toujours une base du système).
- **Années 1930** : premières **assurances sociales** (lois de 1928-1930).
- **1945** : **Plan français de sécurité sociale** de **Pierre Laroque** ; acte fondateur : **ordonnance n° 45-2250 du 4 oct. 1945**.
- **7 août 2020** : loi n° 2020-992 sur la dette sociale et l'autonomie : création de la **5e branche (autonomie)**.

> **LES CINQ BRANCHES DU RÉGIME GÉNÉRAL (ART. L. 200-2 CSS)**
>
> 1. **Maladie**, maternité, invalidité, décès
> 2. **Accidents du travail et maladies professionnelles** (AT-MP)
> 3. **Vieillesse** et veuvage
> 4. **Famille**
> 5. **Autonomie** (depuis 2020)
>
> En matière de **frais de santé**, la protection est **universelle** : toute personne travaillant ou, à défaut, résidant en France de manière stable et régulière en bénéficie (art. L. 160-1 CSS, **protection universelle maladie**, PUMa).

3. Les régimes complémentaires et supplémentaires

	Régimes complémentaires	Régimes supplémentaires
Rôle	Viennent **en parallèle** de la couverture de base	Démarche **facultative**, individuelle ou d'entreprise, pour **améliorer** une couverture déjà assurée par les régimes de base et complémentaires
Caractère	Parfois **obligatoires** (retraite complémentaire), parfois **facultatifs** (mutuelles)	Facultatif
Exemples	**Retraite complémentaire** : AGIRC (cadres, CCN du 14 mars 1947), ARRCO (non-cadres, accord du 8 déc. 1961) ; généralisée par la loi du 29 déc. 1972 ; régime unifié **Agirc-Arrco** (ANI du 17 nov. 2017, applicable au **1er janv. 2019**), en **répartition**. **Complémentaire santé** d'entreprise **obligatoire** depuis le **1er janv. 2016** (loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi) : couverture collective à adhésion obligatoire, **panier minimal**, financée **au moins pour moitié par l'employeur** (art. L. 911-7 CSS) ; autres garanties de prévoyance possibles (décès, incapacité, invalidité, dépendance)	**Plan d'épargne retraite (PER)**, loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 : droits viagers ou capital, payables au plus tôt à la liquidation de la pension ou à l'âge légal (art. L. 224-1 C. mon. fin.)

4. Le chômage

LE CHÔMAGE N'EST PAS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Il relève de la **protection sociale** au sens large : il n'a pas été intégré en 1945 ; il a été mis en place par les **partenaires sociaux** (accord interprofessionnel du **31 déc. 1958**) ; ses règles sont dans le **Code du travail** ; et il était géré par des **associations** (Assedic), non par des organismes de sécurité sociale.

L'Unédic : le pilote

Association créée en **1958** par les partenaires sociaux. Quatre rôles : **financer** les allocations ; veiller à l'**application** des règles ; verser à France Travail une **contribution** d'au moins **10 %** de ses ressources (art. L. 5422-24 C. trav.), fixée à **11 % pour 2026** (environ 5,2 milliards d'euros, près des trois quarts des ressources de l'opérateur) ; définir avec l'État et France Travail les objectifs et en suivre la réalisation.

France Travail : l'opérateur

Institution nationale **publique**, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sous tutelle du ministère du Travail (art. L. 5312-1). Créée par la loi n° 2023-1196 du **18 déc. 2023 pour le plein emploi**, elle remplace **Pôle emploi** le **1er janv. 2024**. Elle verse l'allocation d'assurance chômage pour l'Unédic et les allocations de solidarité pour l'État, et coordonne le « **réseau pour l'emploi** ». **Interlocuteur unique** du demandeur (inscription, attestation employeur ou DSN, litiges).

- **Les règles** : fixées par une **convention d'assurance chômage** négociée par les partenaires sociaux et rendue obligatoire par un **arrêté d'agrément**. Depuis **2019**, l'État encadre la négociation : le Premier ministre transmet un **document de cadrage** (trajectoire financière, objectifs) (art. L. 5422-20-1). Règles actuelles : **convention du 15 nov. 2024**, agréée le 19 déc. 2024, applicable au **1er janv. 2025**, modifiée par l'avenant du 7 juill. 2025 (agréé le 18 févr. 2026). L'État ne compense que partiellement certaines exonérations, ce qui ampute les recettes.
- Depuis le **1er janv. 2025**, les demandeurs du **RSA** et leur conjoint, concubin ou partenaire sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi (art. L. 5411-1), sauf exceptions.
- **Deux volets** : l'**indemnisation** (dépenses passives : un régime d'**assurance** et un régime de **solidarité**, qui relève de l'aide sociale de l'État) et l'**aide au retour à l'emploi** (prospection, placement, formation, bilan de compétences).

5. L'aide et l'action sociale

	Aide sociale (légale)	Action sociale
Principe	**Solidarité** envers les plus démunis, à défaut d'autre protection, pour ceux qui ne peuvent pas pourvoir à leurs besoins (raison financière, physique ou mentale). **Aucune contribution préalable**	**Facultative**
Formes	Aide médicale, aide sociale à l'enfance, personnes âgées, chômeurs (allocations de solidarité), personnes handicapées, **RSA**... En espèces ou en nature	Multiples initiatives
Financement et acteurs	**Impôt** ; gérée surtout par les **collectivités**, principalement le **département** (CASF), compétent selon le **domicile de secours**, sauf prestations limitativement attribuées à l'État (art. L. 121-1 et L. 121-7 CASF)	Associations, caisses de sécurité sociale, collectivités...
Caractères	**Subsidiaire** (après la solidarité familiale et la sécurité sociale) ; stricte réglementation administrative	Libre

II Les enjeux : la « crise de l'État-providence »

L'**État-providence** désigne l'ensemble des interventions sociales de l'État pour garantir un minimum de bien-être à toute la population, notamment par un système étendu de protection sociale ; on l'oppose à l'**État-gendarme**, limité aux fonctions régaliennes.

Crise	Manifestations
De solvabilité	Croissance ralentie, besoins en hausse, prélèvements obligatoires croissants. **Fiscalisation** du financement : les cotisations restent la première ressource, mais passent de **77,8 % (1959) à 55,6 % (2024)** ; les impôts et taxes affectés atteignent **30 %**. Chaque année, une **LFSS** fixe les conditions de l'équilibre (dernière : loi n° 2025-1403 du 30 déc. 2025 pour 2026)
D'efficacité	Les inégalités se creusent malgré la redistribution ; des dispositifs inadaptés à une société transformée (retraites, politique familiale)

De légitimité	Montée de l'**individualisme** ; rejet de mécanismes impersonnels ; effacement des solidarités nationale et professionnelle face aux logiques de **privatisation du risque**

LES RÉFORMES RÉCENTES

- **Retraites** : loi n° 2023-270 du 14 avr. 2023 (LFRSS) : relèvement progressif de l'âge légal à **64 ans**. La **LFSS pour 2026** l'a temporairement **gelé** : **62 ans et 9 mois** pour les assurés nés entre le 1er janv. 1963 et le 31 mars 1965, puis reprise pour atteindre 64 ans pour les assurés nés à partir du **1er janv. 1969** (art. L. 161-17-2 CSS).
- **Vieillissement** : création de la branche **autonomie** (2020).
- **Fraude** : loi n° 2026-534 du **25 juin 2026** relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

FICHE 2

Le système de sécurité sociale en France

I Les grandes étapes de la construction

Dès la fin du XIXe siècle, un « **tournant assurantiel** » : indemniser les victimes sur la base de **risques**. Double mouvement : les ouvriers veulent des droits en plus du salaire ; les employeurs veulent une main-d'œuvre en bon état et en nombre suffisant.

Texte	Apport
Loi du 9 avr. 1898 (accidents du travail, entreprises industrielles)	Avant : responsabilité civile, l'ouvrier devait prouver la **faute** de l'employeur (preuve difficile, infériorité sociale). La loi fonde la responsabilité sur le **risque professionnel** (l'employeur profite du machinisme, il en supporte les risques). Le **compromis de 1898** : responsabilité **automatique** (a priori) de l'employeur, l'ouvrier perdant le droit d'agir contre lui ; en contrepartie, réparation **forfaitaire et partielle** (pas de préjudice esthétique ou moral). Étendu aux **maladies professionnelles** par la loi du **25 oct. 1919** ; toujours le socle des AT-MP
Loi du 5 avr. 1910 (retraites ouvrières et paysannes)	Assurance vieillesse **obligatoire** pour les ouvriers de l'industrie et de l'agriculture gagnant moins de 3 000 F par an ; **capitalisation** ; double cotisation employeur et salarié ; Caisse nationale de retraites pour la vieillesse
Lois du 5 avr. 1928 et du 30 avr. 1930 (assurances sociales)	La loi de 1928, critiquée, est aménagée en 1930 (sous l'impulsion de Pierre Laval) : prise en charge **obligatoire** d'une grande partie des salariés contre la **maladie** et la **vieillesse**
Loi du 11 mars 1932 (« sursalaires »)	Généralisation des **allocations familiales** : affiliation obligatoire des employeurs de l'industrie et du commerce à des **caisses de compensation** agréées. Le législateur consacre une pratique antérieure

II Bismarck, Beveridge et le plan de 1945

Le modèle bismarckien (Allemagne, années 1880)

Premier système cohérent d'assurances sociales, une **assurance collective obligatoire** (discours au Reichstag du 17 janv. 1881 : l'État doit promouvoir le bien-être de tous). L'État intervient, relayé par le monde **professionnel**. Cotisations **proportionnelles aux salaires**, partagées entre employeur et salarié. Lié au **salariat** : **solidarité professionnelle**. Le système français y reste ancré.

Le modèle beveridgien (rapport de 1942)

Social Insurance and Allied Services, naissance du *Welfare State* britannique : un système **généralisé, unique, uniforme**, sans considération de la situation professionnelle ; un **droit de chacun** à la sécurité sociale. **Solidarité nationale** : libérer l'homme du besoin en garantissant une sécurité de revenu.

La France recueille ces **deux héritages contradictoires**.

Le plan français : ordonnance n° **45-2250 du 4 oct. 1945**, qui crée le **régime général** ; artisan : **Pierre Laroque**, haut fonctionnaire du ministère du Travail. L'État fait de la protection sociale une fonction propre. Consécration au **Préambule de 1946**, al. 11 : la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, et des moyens convenables d'existence à qui ne peut pas travailler.

LES « TROIS U » DE BEVERIDGE… PARTIELLEMENT RÉALISÉS EN FRANCE

Principe	Idéal	Réalité française
Universalité	Toute la population, contre tous les risques, « du berceau à la tombe »	Généralisation proclamée par la loi du 22 mai 1946, mais refus des **non-salariés** : juxtaposition de régimes (lois de 1948 pour leur vieillesse, de 1966 pour leur maladie). Universalité de la maladie seulement avec la **CMU** (1999) puis la **PUMa** (2016), fondées sur la **résidence**
Unité (unicité)	Un seul régime, une caisse unique pour tous les risques, un seul financement	Vite affaiblie : **régimes spéciaux** maintenus « provisoirement » (art. 17 de l'ordonnance de 1945)… toujours en place ; régime **agricole** à part ; **CAF** distinctes dès l'origine (mouvement familial) ; **branches** autonomes en 1967. Système **pluraliste**
Uniformité	Cotisations et prestations **forfaitaires**, identiques pour tous (*flat-rate*)	**Rejetée** : cotisations et prestations de remplacement (indemnités journalières, pensions) **proportionnelles** aux salaires. La logique bismarckienne du **maintien du niveau de vie** l'emporte

La « démocratie sociale » : gestion par des **caisses**, organismes de **droit privé chargés d'une mission de service public**, administrées majoritairement par les représentants des **assurés**. Tempérée ensuite : **paritarisme** en 1967 (salariés et employeurs à parité), puis renforcement de la **tutelle de l'État** avec les LFSS (1996).

- **1967** : ordonnances **Jeanneney** (21 août 1967) : branches, trois caisses nationales (CNAMTS, CNAVTS, CNAF) et l'**Acoss**.
- **1991** : création de la **CSG**, premier jalon de la fiscalisation.
- **1996** : loi constitutionnelle du **22 févr. 1996** (LFSS) ; ordonnance du **24 janv. 1996** (CADES, CRDS).
- **1999-2016** : de la **CMU** à la **PUMa**.
- **2018-2020** : suppression du **RSI**, indépendants intégrés au régime général.
- **2020** : 5e branche **autonomie**.
- **2023-2026** : LFRSS 2023 (âge légal relevé, fermeture de régimes spéciaux) ; la LFSS pour 2026 suspend le relèvement de l'âge et de la durée d'assurance jusqu'au **1er janv. 2028**. **2025** : 80 ans de la sécurité sociale.

III Assurance et assistance, branche et régime

▸ A. Entre assurance et assistance

Logique d'assurance (Bismarck)

Anticiper un risque pour en prévoir les conséquences pécuniaires. En sécurité sociale : versement **obligatoire de cotisations** pour prétendre à des **prestations** (en nature ou en espèces) lors de la survenance du risque.

Logique d'assistance (Beveridge)

Une aide qui se déclenche indépendamment de toute prévoyance, du seul fait d'un **état de besoin** : « il est dans le besoin, donc il a droit ». Ex. : **CMU** (loi du 27 juill. 1999, au 1er janv. 2000) ; **PUMa** (art. 59 LFSS 2016) : frais de santé pris en charge sur le seul critère de l'**activité** ou, à défaut, de la **résidence stable et régulière**, à titre personnel et continu (fin de la CMU de base) ; **complémentaire santé solidaire** (fusion de la CMU-C et de l'ACS au **1er nov. 2019**, gratuite ou avec participation selon les ressources, art. L. 861-1 CSS).

▸ B. La branche

Notion structurante : dans le régime général, un ensemble d'institutions (caisse nationale et organismes de base) gérant un **même risque** ; elle transcende les régimes et sert à fixer dans les LFSS des **objectifs par branche**. Créées par les **quatre ordonnances Jeanneney du 21 août 1967**. Cinq branches (art. L. 200-2 CSS) + la branche **recouvrement** (cotisations et recouvrement), qui collecte les ressources des autres. La branche **autonomie** (loi du 7 août 2020) est gérée par la **CNSA** (créée par la loi du 30 juin 2004).

▸ C. Le régime : une « mosaïque »

Une trentaine de **régimes obligatoires de base** (32 selon l'annexe 1 du PLFSS 2025) et des régimes **conventionnels**.

Régime	Bénéficiaires	Organisation
Régime général (le bloc le plus important, l'essentiel des dépenses)	**Salariés** (travailleurs dépendants du commerce, de l'industrie et des services) et **assimilés** (art. L. 311-3 CSS : travailleurs à domicile, VRP, mannequins, artistes du spectacle, journalistes, dirigeants de certaines sociétés…). Depuis la suppression du **RSI** (LFSS 2018, transition achevée le 1er janv. 2020), aussi les **indépendants**, avec des règles propres de cotisations et de prestations	**Caisses nationales** : **Cnam** (maladie et AT-MP), **Cnaf** (famille), **Cnav** (retraites), **CNSA** (autonomie), **Acoss**, devenue « **Urssaf Caisse nationale** » (recouvrement). **Réseau local** : **CPAM** (départementales, droit privé, mission de service public : maladie et AT) ; **Carsat** (régionales : retraites, action sociale vieillesse, partie AT ; en Île-de-France, la Cnav directement) ; **CAF** (départementales : famille, logement, insertion) ; **Urssaf** (régionales : recouvrement et contrôles)
Régime agricole	Exploitants agricoles et leurs familles, salariés agricoles, contre tous les risques ; déficitaire (déclin du secteur primaire)	« **Guichet unique** » : Caisse centrale de la **MSA** (compensation, contrôle) et caisses départementales ou pluridépartementales
Régimes spéciaux (liste : art. R. 711-1 CSS)	Fonctionnaires de l'État, magistrats, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, marins, mines, SNCF, IEG, Banque de France, Opéra de Paris, Comédie-Française… Certains couvrent tous les risques (SNCF, RATP), d'autres une partie. Avantages souvent supérieurs (autonomie de gestion, droits acquis avant 1946). Certains sont en extinction (mines)	**Fermetures** : SNCF (réforme ferroviaire de 2018) ; au **1er sept. 2023** (LFRSS du 14 avr. 2023), **RATP**, **IEG**, **Banque de France**, **clercs de notaires** (CRPCEN) et **CESE** : les nouveaux recrutés relèvent du régime général (« **clause du grand-père** » pour les agents en place)
Régimes complémentaires (conventionnels)	**Obligatoires** : seulement la vieillesse des salariés (**Agirc-Arrco**, ANI du 17 nov. 2017, fusion au 1er janv. 2019). **Facultatifs** : mutuelles, sauf la complémentaire santé collective obligatoire en entreprise depuis 2016 (art. L. 911-7)	—

IV L'organisation financière du régime général

▸ A. Les types de prestations

Contributives / non contributives

Contributives (logique d'assurance) : proportionnalité avec les cotisations versées (ex. : droit aux prestations maladie si l'assuré a contribué au financement du risque). **Non contributives** (logique d'assistance) : lien avec les cotisations relâché ou inexistant.

En espèces / en nature

En espèces : un **revenu de remplacement** (indemnités journalières, pensions d'invalidité), sous conditions d'activité ou de cotisations, calculé sur les revenus antérieurs. **En nature** : prise en charge de **dépenses** (actes, médicaments, appareils, hospitalisation, transport) ou financement direct de services (aide-ménagère).

▸ B. Les recettes : cotisations et fiscalisation

1. Les cotisations (logique assurantielle et professionnelle d'origine)

- **Partage** entre employeur et salarié, sauf famille et AT-MP (employeur seul). Principe érodé : depuis **2018**, plus de cotisation salariale **maladie** ni **chômage** dans le privé, en contrepartie d'une hausse de **1,7 point de CSG** (LFSS 2018, art. 8) ; la part salariale porte surtout sur la **vieillesse**.
- **Proportionnalité** aux salaires (un pourcentage).
- **Obligation** d'ordre public, liée au droit aux prestations (une contribution qui ouvre droit, potentiellement, aux prestations). Dérogations : **exonérations** sans perte de droits ; depuis la loi du **25 juill. 1994**, toute nouvelle exonération doit en principe être **compensée intégralement** par l'État (art. L. 131-7 CSS), sauf exceptions légales.
- **Taux réglementaires**, **uniformes** par risque, sauf les AT-MP.

LA TARIFICATION AT-MP : RESPONSABILISER PAR LA PRÉVENTION

Le taux varie selon la **taille** et la **sinistralité** : plus le risque est grand, plus la cotisation est élevée (art. D. 242-6-2 CSS). **Moins de 20 salariés** : taux **collectif** (sinistralité du secteur). **20 à 149** : taux **mixte** (secteur et entreprise, de plus en plus individualisé avec l'effectif). **150 et plus** : taux **individuel**.

2. Les contributions (fiscalisation)

- **Taxes affectées**, logique « **pollueur-payeur** » (pénaliser les comportements coûteux) : primes d'assurance automobile, boissons alcoolisées (1983), premix, publicité pharmaceutique, tabacs, produits alimentaires, C3S et contribution additionnelle, médicaments…

	CSG (1991)	CRDS (1996)
Création	Loi de finances pour **1991**, d'abord pour la branche famille, au taux de **1,1 %**	Ordonnance du **24 janv. 1996**, avec la **CADES** (apurement de la dette sociale)
Assiette	**Tous les revenus** (pas seulement salariaux) : plus large que l'impôt sur le revenu et les cotisations. CSG : quatre contributions (activité et remplacement, patrimoine, placements, jeux)	

Taux	**Proportionnel** (non progressif). **9,2 %** sur les revenus d'activité (art. L. 136-8) ; **8,3 %** retraites et invalidité ; **6,2 %** chômage et indemnités journalières ; 6,6 % ou 3,8 % selon le revenu fiscal de référence. LFSS 2026 : **10,6 %** pour la plupart des revenus du patrimoine et de placement (9,2 % pour les revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement…)	**0,5 %** uniforme (sauf minima sociaux)
Nature et gestion	« **Imposition de toutes natures** » (art. 34 C.), et non cotisation ; taux proportionnel unique conforme à l'art. 13 DDHC (CC, **90-285 DC, 28 déc. 1990**). Recouvrée par l'**Urssaf** (activité, remplacement) et les **services fiscaux** (patrimoine, capital)	Durée de la CADES plusieurs fois prolongée : reprise de **136 milliards** d'euros (lois du 7 août 2020), extinction de la dette sociale repoussée à **2033**

▸ C. Le pilotage : les lois de financement de la sécurité sociale

> **ART. 34 ET 47-1 DE LA CONSTITUTION (LC DU 22 FÉVR. 1996)**
>
> Les LFSS « déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses ». Chaque automne, le Parlement vote les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses **par branche** et l'**ONDAM** (objectif national de dépenses d'assurance maladie). Cadre organique refondu par la loi organique n° **2022-354 du 14 mars 2022**.

FICHE 3

L'aide sociale, l'action sociale et l'assurance chômage

I Aide sociale et action sociale

Origines : premières lois à la fin du XIXe et au début du XXe siècle (loi de **1893** sur l'assistance médicale gratuite ; loi du **14 juill. 1905** sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables), inspirées du devoir de subsistance publique posé à la Révolution.

> **CONGRÈS INTERNATIONAL D'ASSISTANCE (1889) : LES FONDEMENTS DE L'AIDE SOCIALE MODERNE**
>
> L'assistance publique est due à ceux qui sont, temporairement ou définitivement, dans l'**impossibilité physique** de pourvoir aux nécessités de la vie ; elle n'est due qu'**à défaut d'une autre assistance** (subsidiarité) ; elle est d'**essence communale** (la commune connaît les bénéficiaires).

Longtemps laissé aux institutions caritatives et religieuses (le Secours catholique et le Secours populaire jouent toujours un rôle), le secours aux démunis aurait pu sembler voué à décliner en 1945. Mais l'assistance classique est restée **irremplaçable**, et l'**action sociale**, facultative et pas seulement charitable, s'est développée.

	Aide sociale	Action sociale
Définition	Un ensemble de prestations (en nature ou en argent) correspondant à des **droits subjectifs**, **spécialisés**, à caractère **alimentaire**, attribués **sans contribution préalable** ; une **obligation légale** des collectivités publiques face à un état de besoin	Pas de définition précise ; un ensemble d'interventions **libres ou discrétionnaires**, qui pallient les carences des autres aides ou les complètent et les élargissent. Également sans contribution préalable
Caractère	**Obligatoire** pour la personne publique	Simple **faculté**
Formes	Aides légales spécialisées (voir ci-dessous)	Aides directes (aide-ménagère), indirectes (aides à l'emploi), équipements et services collectifs (crèches)
Acteurs	Toujours des **collectivités publiques** (qui peuvent associer des privés)	**Pluri-institutionnelle** : État, collectivités, établissements publics, caisses de sécurité sociale, personnes privées

Focus : le droit à l'aide sociale

ART. L. 111-1 CASF

« Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale. » Corollaire du devoir de la collectivité posé par l'al. 11 du Préambule de 1946.

Un droit alimentaire et spécialisé

Sa **cause** est le **besoin** (« un manque qui produit des effets de droit »). Ni indemnité ni libéralité : il est dû pour faire vivre son titulaire et sa famille, s'impose absolument au débiteur et dure tant que le besoin dure. **Spécialisation** : chaque forme répond à un besoin déterminé, avec un statut distinct.

Un droit subjectif

Apprécié selon la **situation individuelle** ; une prérogative opposable à la puissance publique, tenue d'y faire droit, d'où un **droit de recours**. Ni absolu (encadré par les textes) ni général (subordonné au besoin). Depuis l'ordonnance du 1er déc. 2005 (au 1er janv. 2007), les commissions d'admission ont disparu : décision du **président du conseil départemental** ou du **préfet** (L. 131-2) ; **recours administratif préalable obligatoire** avant tout recours contentieux (L. 134-2).

Un droit subsidiaire, conséquence de son caractère alimentaire. Chacun doit d'abord subvenir à ses besoins (travail, patrimoine) ; l'aide sociale n'intervient qu'**après** :

- les **ressources personnelles** ;
- les droits issus de la **sécurité sociale** (épuisés ou inexistants) ;
- la **solidarité familiale** : les débiteurs de l'**obligation alimentaire** (art. 205 s. C. civ.) indiquent l'aide qu'ils peuvent apporter ou prouvent leur impossibilité (art. L. 132-6 CASF).

LES DISPENSES D'OBLIGATION ALIMENTAIRE (ART. L. 132-6 CASF)

Sont dispensés : les enfants **retirés de leur milieu familial** par décision judiciaire au moins **36 mois cumulés** avant leurs 18 ans ; les enfants dont un parent a été condamné pour un **crime ou une agression sexuelle sur l'autre parent** (pour l'aide au parent condamné) ; depuis la loi n° **2024-317 du 8 avr. 2024** (« bien-vieillir », art. 23), les **petits-enfants** pour l'aide sociale à l'**hébergement** d'un grand-parent. Les dispenses s'étendent aux descendants (sauf décision contraire du JAF dans les deux premiers cas).

LES RECOURS EN RÉCUPÉRATION (ART. L. 132-8 CASF)

Exercés par l'État ou le département contre : le bénéficiaire **revenu à meilleure fortune** ; sa **succession** ; le **donataire** (donation postérieure à la demande ou dans les **10 ans** qui la précèdent) ; le **légataire** ; à titre subsidiaire, le bénéficiaire d'une **assurance-vie**, à concurrence des primes versées après **70 ans**.

Les acteurs et les catégories d'aide sociale légale

- **Département** : « **chef de file** » (art. L. 121-1 CASF) : il définit et met en œuvre la politique d'action sociale et coordonne les actions ; les prestations légales sont à la charge du département du **domicile de secours**, sauf celles de l'État.
- **État** (art. L. 121-7) : personnes présentes en France du fait de circonstances exceptionnelles ou sans domicile fixe déterminable (L. 111-3), **aide médicale de l'État**, logement, hébergement et réinsertion. Pilotage régional par les **ARS**, les **DREETS** (depuis le 1er avr. 2021) et les préfets de région.
- **Communes** : **CCAS** et CIAS.

Aide	Compétence	Contenu
Aide sociale à l'enfance (ASE)	Département	Premier poste budgétaire départemental ; aide et action sociale imbriquées ; **pas subsidiaire**. Intérêt de l'enfant, maintien de préférence dans la famille d'origine. Missions (L. 221-1) : **PMI**, pupilles de l'État, mineurs en danger ou en risque (informations préoccupantes), mineurs maltraités, mineurs émancipés et majeurs de moins de **21 ans** en grande difficulté, femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de 3 ans. Actions collectives de prévention ; actions individuelles (secours d'urgence, allocations mensuelles, aide-ménagère) ; placements. Les mineurs délinquants relèvent surtout de l'État (PJJ)
Aide médicale de l'État (AME)	État	Accès aux soins des **étrangers en situation irrégulière** résidant en France de façon ininterrompue depuis **plus de 3 mois**, sous le plafond de ressources de la complémentaire santé solidaire (L. 251-1). Accordée pour **1 an**, renouvelable chaque année. Décret n° **2026-67 du 6 févr. 2026** (au 1er avr. 2026) : pièces justificatives renforcées (acte de naissance, pièce d'identité avec photo pour les majeurs, justificatifs de résidence de moins de 12 mois, justificatif de soins pour la prise en charge rétroactive) ; décret n° 2026-66 sur la consultation du fichier ; première demande en principe **en personne** à la CPAM
Personnes âgées	Département	Revenu minimal, maintien à domicile, insertion. Dépendance : **APA** (allocation personnalisée d'autonomie) pour toute personne âgée résidant en France incapable d'assumer les conséquences de la perte d'autonomie (L. 232-1). Branche autonomie (2020, CNSA) ; loi « bien-vieillir » du 8 avr. 2024
Personnes handicapées	Département	Loi d'orientation du **30 juin 1975** (recul de l'aide sociale au profit de la sécurité sociale ; maintien à domicile, insertion) ; loi du **11 févr. 2005** pour l'égalité des droits et des chances : **PCH** (prestation de compensation du handicap, L. 245-1). L'**AAH**, prestation de sécurité sociale, est « **déconjugalisée** » (loi du 16 août 2022, au plus tard au 1er oct. 2023) : les revenus du conjoint ne comptent plus
Hébergement et réinsertion sociale	État	Créée en 1953, rénovée par la loi du **19 nov. 1974** : subsidiaire, temporaire, liée au besoin, spécialisée. Hébergement et prestations de réinsertion, surtout en **CHRS** (L. 345-1 : personnes et familles en graves difficultés, pour recouvrer leur autonomie)

LE CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE

Réformé par la loi **J21** du 18 nov. 2016 (au **1er janv. 2019**) : suppression des commissions départementales et de la Commission centrale d'aide sociale ; compétence des seules **juridictions de droit commun**, après RAPO (L. 134-2). **Juge judiciaire** (L. 134-3) : obligation alimentaire (L. 132-6), recours en récupération (L. 132-8), allocation différentielle aux adultes handicapés (L. 241-2), **PCH** (L. 245-2). Tout le reste : **juge administratif**.

Aide sociale ≠ minima sociaux : les minima sociaux garantissent un **revenu minimal** aux personnes précaires, prestations **non contributives**. Pas un minimum unique mais **dix dispositifs**, chacun pour une population : **RSA**, RSO (outre-mer), **ASS** (allocation de solidarité spécifique), **ADA** (demandeurs d'asile), allocation veuvage, **ASI** (supplémentaire d'invalidité), **AAH**, **ASPA** (personnes âgées) ; l'AER-R et l'ATA sont en extinction (2011 et 2017).

II L'assurance chômage

Une assurance…

Depuis **1958**, elle protège tous les salariés du **privé** (et certains du public) qui perdent leur emploi : une **allocation** calculée sur l'**ancien salaire** et des aides au retour à l'emploi. **Obligatoire** : tous les employeurs du privé (et certains du public) cotisent.

… et solidaire

Elle **mutualise** les risques et compense mieux la perte d'un bas salaire que d'un haut revenu. Financement : **contributions patronales** et **impositions affectées** à l'Unédic (L. 5422-9) ; les salariés de droit commun ne cotisent plus (depuis 2018).

- **Bénéficiaires** (L. 5422-1) : salariés privés d'emploi de façon **involontaire** ; aussi, sous conditions, en cas de **rupture conventionnelle** et pour les **démissionnaires** ayant un projet réel et sérieux de reconversion ou de création ou reprise d'entreprise.
- **Gestion paritaire** : depuis 1958, les partenaires sociaux négocient tous les 2 ou 3 ans les règles d'indemnisation, les taux de cotisation et les aides, et gèrent le régime par l'**Unédic**, association paritaire de droit privé.
- **Encadrement par l'État** depuis la loi n° **2018-771 du 5 sept. 2018** : **document de cadrage** du Premier ministre (L. 5422-20-1) ; l'accord ne s'applique qu'après **agrément** par arrêté. Versement par **France Travail** pour le compte de l'Unédic depuis le 1er janv. 2024 (L. 5312-1).

LA CONDITION D'AFFILIATION

Avoir travaillé en principe **au moins 6 mois (130 jours ou 910 heures)** au cours des **24 derniers mois** (**36 mois** pour les salariés les plus âgés) ; **5 mois** pour les **primo-entrants** (convention du 15 nov. 2024).

FICHE 4

Assurance maladie, maternité et AT-MP (régime général)

I L'assurance maladie

La sécurité sociale est souvent confondue avec l'assurance maladie, qui n'en est qu'une **composante**. Double objectif : faire face aux **dépenses de santé** de l'assuré et de ses proches (**prestations en nature**) ; compenser la **perte de salaire** liée à l'impossibilité de travailler (**prestations en espèces**).

1. De 1945 à la protection universelle maladie

Opération	Définition
Identification (ex-immatriculation)	Vérifier l'identité (état civil) pour attribuer le **NIR** (numéro de sécurité sociale), attribué dès la naissance par l'**INSEE** pour les personnes nées en France
Assujettissement	Rattacher un travailleur à un **régime** (ex. : le régime général). Âge, nationalité ou qualité de salarié sont indifférents : compte la **nature de l'activité** et ses conditions d'exécution ; il faut être reconnu **travailleur dépendant**
Affiliation	Rattacher l'assuré à la **caisse** qui lui versera ses prestations : en principe la **CPAM** de sa résidence habituelle (art. R. 312-1 CSS)

- **1945** : un système fondé sur le **travail** : il faut avoir cotisé pour avoir droit aux prestations.
- **1999** (date majeure) : **CMU de base** contre l'exclusion des soins, pour les personnes aux faibles ressources sans protection ; **CMU-C** (situation régulière, résidence en France depuis plus de 3 mois, ressources sous plafond).
- **1er janv. 2016** : **PUMa** (art. L. 160-1 CSS) : toute personne travaillant ou, à défaut, résidant en France de manière **stable et régulière** bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé, droit **personnel et continu** tout au long de la vie.
- **1er nov. 2019** : la CMU-C devient la **complémentaire santé solidaire (C2S)** : gratuite sous un plafond de ressources, avec participation entre ce plafond et le plafond majoré de **35 %** (art. L. 861-1).

Conditions simplifiées par la PUMa : **salariés** : plus d'activité minimale, seul compte l'exercice d'une activité ; **indépendants** : droits dès le début de l'activité ; **sans activité** : au seul titre de la résidence.

> **ATTENTION**
> La PUMa ne concerne que les **frais de santé**. Les **indemnités journalières** restent subordonnées à des conditions d'**activité ou de cotisation**.

2. Les prestations en nature

Remboursement des actes médicaux et paramédicaux, médicaments, appareils, hospitalisations, transports, et certaines vaccinations et actions de **prévention** (médecine préventive et curative). Une **assurance remboursement** : l'assuré avance les frais puis est remboursé, sauf **tiers payant**. Pour être bien remboursé : le **parcours de soins coordonnés** (consulter d'abord son **médecin traitant**), sauf pour les moins de **16 ans** et les spécialistes en **accès direct**.

Reste à charge	Contenu (au 1er oct. 2026)
Ticket modérateur	La part des dépenses qui reste à la charge de l'assuré après le remboursement de l'assurance maladie, sur tous les frais remboursables. Son taux varie selon le risque (maladie, maternité, invalidité, AT-MP), l'acte et le respect du parcours de soins. Souvent pris en charge par la complémentaire
Participation forfaitaire	**2 €** (et non plus 1 €) pour les 18 ans et plus, par consultation ou acte d'un médecin, examen de radiologie ou analyse de biologie (art. L. 160-13 II et R. 160-19). Plafond : **35 participations, soit 70 € par an** à compter du 1er oct. 2026 (art. D. 160-6, décret du 11 sept. 2026)
Franchise médicale	Déduite des remboursements : **1 €** par boîte de médicament, **1 €** par acte paramédical, **4 €** par transport (art. D. 160-9, depuis le 31 mars 2024). Plafond annuel porté de **50 à 70 €** au 1er oct. 2026 (D. 160-10), revalorisé sur l'inflation à partir de 2028
Forfait journalier hospitalier	Participation aux frais d'hébergement (art. L. 174-4) : **23 € par jour** (**17 €** en psychiatrie) depuis le 1er mars 2026 ; exonérations (maternité, AT-MP notamment)

LES TROIS ÉTAGES

La **PUMa** rembourse la **part obligatoire**. Le reste à charge peut être couvert par une **complémentaire santé ou** par la **C2S** (qui la remplace sous plafond de ressources) : les deux **ne se cumulent pas**.

3. Les prestations en espèces : les indemnités journalières (IJ)

Un **substitut de salaire** quand l'incapacité de continuer ou de reprendre le travail est constatée par un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste (art. L. 321-1).

- **Ouverture du droit** : conditions de durée d'activité salariée ou de cotisations à la date de l'arrêt, et en plus une durée d'**affiliation** pour les arrêts de plus de **6 mois** (art. R. 313-3).
- **Carence** : IJ dues à partir du **4e jour** (3 jours de carence : L. 323-1, R. 323-1).
- **Montant** : **50 %** du revenu d'activité antérieur ramené à une valeur journalière (R. 323-5), dans la limite de **1,4 SMIC** mensuel pour les arrêts débutant depuis le **1er avr. 2025** (R. 323-4, décret du 20 févr. 2025).
- **Durée des arrêts prescrits** (LFSS 2026, art. 81, depuis le **1er sept. 2026**) : arrêt initial de **31 jours** au plus, prolongation de **62 jours** au plus, sauf justification par le prescripteur (L. 162-4-1, L. 162-4-4, R. 162-1-7-1).
- **Durée d'indemnisation** : **360 IJ** au plus sur **3 ans** (affections ordinaires) ; **3 ans** pour les **ALD** exonérantes ; pour les arrêts prescrits depuis le **15 oct. 2026**, **1 an** pour les ALD non exonérantes (R. 323-1, décret du 16 sept. 2026).

L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE DE L'EMPLOYEUR (ART. L. 1226-1 C. TRAV.)

Conditions : **1 an d'ancienneté** ; justifier de l'incapacité dans les **48 heures** ; être pris en charge par la sécurité sociale ; être soigné en France ou dans l'UE ou l'EEE. Versée après **7 jours** d'absence (dès le premier jour pour un AT-MP, hors accident de trajet). Elle porte la rémunération à **90 %** du salaire brut pendant **30 jours**, puis aux **deux tiers** les 30 jours suivants (D. 1226-1 et D. 1226-3), durées allongées avec l'ancienneté ; souvent améliorée par les conventions collectives. L'employeur peut organiser une **contre-visite**. Depuis le **27 juin 2026**, exclue en cas de **fraude avérée** du salarié aux IJ dont l'employeur a été informé.

Obligations de l'assuré : respecter les prescriptions ; si les sorties sont autorisées, être présent au domicile de **9 h à 11 h et de 14 h à 16 h** (sauf soins ou sorties libres médicalement justifiées : R. 323-11-1) ; ne pas quitter la circonscription sans autorisation ; aucune activité non autorisée.

II L'assurance maternité

Trois objectifs : couvrir les **frais de santé** (L. 160-9) ; verser des **IJ** et allocations aux femmes dispensées de travail (L. 331-3 à L. 331-7, L. 333-1 à L. 333-3) ; indemniser le **congé de paternité et d'accueil de l'enfant** (L. 331-8) et le **congé supplémentaire de naissance** (L. 331-8-1). Même champ que l'assurance maladie (L. 160-1).

Prestations en nature : prise en charge intégrale

« L'assuré et ses ayants droit ne supportent **aucune participation** » (L. 160-9) : frais médicaux, pharmaceutiques, analyses, appareils, hospitalisation, liés ou non à la grossesse. Période : de **4 mois avant** la date présumée de l'accouchement (1er jour du 6e mois) à **12 jours après** (D. 160-3). Exonérations : ticket modérateur, participation pour actes lourds, participation de 2 €, franchises, forfait journalier.

Prestations en espèces : les congés

- **Maternité** (1er ou 2e enfant) : **6 semaines avant** et **10 semaines après** l'accouchement (L. 1225-17) ; IJ si la salariée cesse tout travail au moins **8 semaines** (L. 331-3). Conditions : celles des arrêts maladie de 6 mois au plus (150 heures sur 3 mois ou cotisations sur 1 015 SMIC horaires sur 6 mois) et **6 mois d'affiliation** à la date présumée de l'accouchement.
- **Paternité et accueil de l'enfant** : **25 jours** calendaires (32 en cas de naissances multiples) : 4 jours consécutifs juste après le congé de naissance, puis 21 jours (L. 1225-35).
- **Congé supplémentaire de naissance** (LFSS 2026, ouvert depuis le **1er juill. 2026**) : pour chaque parent salarié, après les congés de maternité, paternité ou adoption ; **1 ou 2 mois** au choix, fractionnable en deux périodes d'un mois ; suspend le contrat (L. 1225-46-2) ; IJ égale à une fraction des revenus antérieurs, éventuellement dégressive (L. 331-8-1).

III Les accidents du travail et les maladies professionnelles

Trois risques : l'**accident du travail**, l'**accident de trajet**, la **maladie professionnelle**.

1. La reconnaissance

L'ACCIDENT DU TRAVAIL (ART. L. 411-1 CSS)

« Est considéré comme accident du travail, **quelle qu'en soit la cause**, l'accident survenu **par le fait ou à l'occasion du travail** » à toute personne visée à l'art. L. 311-2. D'où une **présomption d'imputabilité** : l'accident survenu **au temps et au lieu du travail** est présumé professionnel, sauf preuve d'une cause **totalement étrangère** au travail.

L'ÉLARGISSEMENT DE LA NOTION : SOC., 2 AVR. 2003, N° 00-21.768

Ancienne définition : « l'action **violente et soudaine** d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme » (la **soudaineté** le distingue de la maladie professionnelle). Désormais : « un **événement ou une série d'événements** survenus à des **dates certaines** par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, **quelle que soit la date d'apparition** de celle-ci ». Des lésions tardives n'empêchent plus la reconnaissance si l'événement a une date certaine.

L'accident de trajet (art. L. 411-2) : sur l'aller et retour entre : la résidence principale, une résidence secondaire stable ou un lieu fréquenté habituellement pour des motifs familiaux, et le **lieu de travail** ; le lieu de travail et le **lieu habituel des repas** (restaurant, cantine). Parcours **ni interrompu ni détourné** pour un motif d'intérêt personnel étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ; un détour imposé par un **covoiturage régulier** est admis. **Pas de présomption** : la victime doit prouver ces conditions (sauf présomptions suffisantes issues de l'enquête).

La maladie professionnelle : une atteinte à l'intégrité physique ou psychique résultant d'une **lente atteinte** de l'organisme ; identification et causalité difficiles, d'où trois voies de reconnaissance (art. L. 461-1) :

Voie	Conditions	Instruction
1. Présomption (maladie « présumée »)	Maladie **désignée dans un tableau** et contractée dans les conditions du tableau (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste des travaux)	Caisse
2. Tableau, condition manquante	Une ou plusieurs conditions (délai, durée d'exposition, liste limitative des travaux) ne sont pas remplies, mais il est établi que la maladie est **directement causée** par le travail habituel (pas forcément cause unique ou essentielle : Soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097)	Avis motivé du **CRRMP**, qui s'impose à la caisse ; LFSS 2026 : si seul le **délai** n'est pas respecté, examen par un **collège de deux médecins-conseils** (le CRRMP étant recentré sur les dossiers complexes ; mise en œuvre subordonnée à des textes réglementaires)
3. Hors tableau	Maladie caractérisée **non désignée**, **essentiellement et directement** causée par le travail habituel, ayant entraîné le **décès** ou une incapacité permanente d'au moins **25 %** (R. 461-8). Voie des **pathologies psychiques**	Avis du **CRRMP**

Les tableaux évoluent : décret n° 2025-1349 du 26 déc. 2025 : tableaux n° 16 bis et n° 30 (**amiante**) complétés pour les activités de **lutte contre les incendies** (pompiers professionnels et volontaires) et, pour le n° 30, de sauvetage et déblaiement lors d'effondrements.

2. L'indemnisation : le compromis de 1898

Une réparation **forfaitaire**, graduée selon la gravité (incapacité temporaire, permanente, décès) ; en contrepartie, la victime **perd l'action en responsabilité civile** de droit commun contre l'employeur, même si la réparation est partielle.

	Maladie (non professionnelle)	AT-MP
Soins	Ticket modérateur, franchises, forfaits	**Gratuité** : réglés directement par la caisse ; exonération du ticket modérateur et du forfait journalier ; **tiers payant**
Jour de l'accident	—	Intégralement payé par l'**employeur**
Carence	3 jours	**Aucune** : IJ dès le lendemain (L. 433-1)
Montant des IJ	50 % (plafond 1,4 SMIC)	**60 %** du salaire journalier les **28 premiers jours**, puis **80 %** dès le 29e (R. 433-1, R. 433-3)
Durée	360 IJ sur 3 ans ; ALD 3 ans	LFSS 2026 : durée maximale fixée par décret, au terme de laquelle l'incapacité est réputée **permanente** (sauf travail aménagé ou temps partiel thérapeutique)

- **Incapacité permanente** : taux fixé par le service médical. Moins de **10 %** : **indemnité en capital** (L. 434-1) ; au-delà, **rente**. **Décès** : rente aux ayants droit (conjoint ou assimilé, enfants à charge, ascendants).
- **Versement de la rente** : trimestriel jusqu'au 31 oct. 2026 (mensuel si taux d'au moins 50 %) ; **mensuel** à partir du **1er nov. 2026** (au 1er janv. 2028 pour les rentes notifiées avant ; décret du 7 mai 2026).

La faute inexcusable (art. L. 452-1 CSS)

De l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction. Plus rattachée à une « obligation de sécurité de résultat », mais à l'**obligation légale de sécurité** (L. 4121-1 et L. 4121-2 C. trav.) : le manquement est une faute inexcusable lorsque l'employeur **avait ou aurait dû avoir conscience du danger** et n'a **pas pris les mesures nécessaires** pour en préserver le travailleur (Civ. 2e, **8 oct. 2020**, n° 18-25.021). Reconnue par accord amiable ou par le **pôle social du tribunal judiciaire**. Effets : **majoration de la rente** et réparation des préjudices ; depuis CC, **2010-8 QPC du 18 juin 2010**, réparation de **l'ensemble des dommages non couverts** par le livre IV.

La faute intentionnelle (art. L. 452-5 CSS)

L'**intention de nuire** et la volonté de causer des lésions corporelles : acte ou omission volontaire de l'employeur (coups et blessures volontaires) ou d'un préposé (jeter un objet sur un collègue pour le blesser). La victime ou ses ayants droit conservent contre l'**auteur** l'action de **droit commun** pour le préjudice non réparé par le livre IV.

SYNTHÈSE

L'essentiel à retenir

Les distinctions clés

- **Protection sociale** (large) ⊃ **sécurité sociale** + aide sociale + chômage + complémentaires
- **Assurance** (Bismarck, cotisations, solidarité professionnelle) / **assistance** (Beveridge, besoin, solidarité nationale)
- **Aide sociale** (obligatoire, droit subjectif, subsidiaire) / **action sociale** (facultative)
- Prestations **contributives** / **non contributives** ; **en nature** / **en espèces**
- **Régimes complémentaires** / **supplémentaires**
- **Branche** (un risque) / **régime** (une population)
- **Identification** / **assujettissement** / **affiliation**
- **Accident du travail** (présomption) / **de trajet** (preuve) / **maladie professionnelle** (tableaux)

Les dates clés

- **1893** AMG · **1898** AT · **1905** assistance aux vieillards · **1910** retraites ouvrières · **1919** MP
- **1928-1930** assurances sociales · **1932** allocations familiales
- **1942** rapport Beveridge · **4 oct. 1945** ordonnance · **1946** Préambule al. 11
- **1958** assurance chômage, Unédic · **1967** ordonnances Jeanneney
- **1991** CSG · **1996** LFSS, CADES, CRDS · **1999** CMU
- **2005** loi handicap, PCH · **2016** PUMa, complémentaire santé obligatoire · **2019** C2S, Agirc-Arrco
- **2020** branche autonomie, fin du RSI · **2023** retraites, régimes spéciaux fermés · **2024** France Travail
- **2026** LFSS : gel de l'âge légal, congé de naissance, plafonnement des arrêts

Les chiffres

- 932,5 Md€ de prestations, 31,9 % du PIB (2024)
- Cotisations : 55,6 % des ressources ; impôts et taxes : 30 %
- CSG : 9,2 % (activité), 8,3 %, 6,2 %, 10,6 % (patrimoine) ; CRDS : 0,5 %
- IJ maladie : 50 %, carence 3 jours, plafond 1,4 SMIC ; IJ AT : 60 % puis 80 %
- Participation forfaitaire 2 € (plafond 70 €) ; franchises 1 € / 1 € / 4 € (plafond 70 €) ; forfait hospitalier 23 €
- Chômage : 6 mois (130 jours ou 910 h) sur 24 mois
- MP hors tableau : 25 % d'incapacité ; IP : capital sous 10 %

Les décisions

- CC, 90-285 DC, 28 déc. 1990 : la CSG est une imposition de toutes natures
- CC, 2010-8 QPC, 18 juin 2010 : faute inexcusable, réparation de tous les dommages non couverts
- Soc., 19 déc. 2002 : MP, pas de cause unique exigée
- Soc., 2 avr. 2003 : nouvelle définition de l'AT
- Civ. 2e, 8 oct. 2020 : faute inexcusable et obligation légale de sécurité

Fiche réalisée d'après les quatre fiches du cours d'Initiation au droit de la protection sociale de Céline Leborgne-Ingelaere (Université de Lille, 2026-2027).